

08 - 01- Maladie Inflammatoire du Pelvis (PID) - Pr. Asmouki

Je vais vous parler de la maladie inflammatoire du pelvis. Par rapport au diaporama de l'année dernière, j'ai fait quelques mises à jour. Il faut tenir compte du diaporama de cette année.

Il y a eu quelques modifications, des choses que j'ai retirées, des choses que j'ai ajoutées, des choses que j'ai changées. Donc, si vous voulez préparer, si vous voulez réviser, il vaut mieux que ce soit sur ce diaporama. Donc, comme son nom l'indique, maladie inflammatoire du pelvis, on l'appelait auparavant les salpingites aiguës.

Alors, les salpingites aiguës, ça ne traduit pas exactement ce qui se passe sur le plan pathologique. Donc, le terme le plus proche, c'est une maladie inflammatoire du pelvis parce que dès qu'il y a une atteinte de trempage, tout le pelvis, tout le bas pelvis va être inflammé et c'est ce qui va causer tous les problèmes qui vont suivre, notamment le risque de GU, le risque de stérilité et le risque de douleurs pelviennes chroniques. Donc, c'est ça, la maladie inflammatoire du pelvis, pelvic inflammatory disease des anglo-saxons.

Donc, les Français, ils appellent ça les salpingites ou bien les infections génitales hautes. On peut également les appeler infections génitales hautes. Le terme le plus adéquat, c'est la maladie inflammatoire du pelvis, d'accord? Donc, comme généralité, il ne veut pas défigurer, voilà alors déjà, qui dit infections génitales hautes ou bien maladies inflammatoires du pelvis, il faut savoir diagnostiquer l'élément important dans ce chapitre, c'est le diagnostic et le traitement, bien sûr, la prévention, le diagnostic.

Donc, il faut savoir diagnostiquer et traiter une gonococcie ou une chlamydiose. Déjà, dès le départ, la maladie inflammatoire du pelvis dans plus de 85% des cas, c'est dû à une infection sexuellement transmissible. C'est une maladie sexuellement transmissible ou une infection sexuellement transmissible dans 15% des cas, c'est dû à autre chose, notamment les gestes, les manœuvres ou bien les gestes en utérin.

Donc, souvent, on va parler de maladies sexuellement transmissibles ou d'infections sexuellement transmissibles. C'est pour cela que le chlamydia et le gonocoque sont de loin les germes les plus rencontrés dans ce contexte-là. Donc, diagnostiquer et traiter, colloquer les principes de prévention, c'est très important et du dépistage des infections sexuellement transmissibles, notamment chez les partenaires.

Donc, actuellement, dans notre contexte marocain, avant le mariage, on demande aux deux partenaires un certificat médical qui atteste qu'ils n'ont pas de maladies, notamment de maladies sexuellement transmissibles. Ce qui fait qu'il faut savoir ce qu'il faut faire comme examen, comme bilan pour donner ce certificat. La plupart des médecins le donnent que par l'examen clinique et ils le précisent dans le certificat après avoir examiné cliniquement.

Mais pour faire les choses dans les règles de l'art, il faut vraiment faire un bilan d'infections

sexuellement transmissibles. D'accord. Notamment chez les partenaires, le plan, c'est un plan classique, généralité, l'importance des facteurs de risque, un peu de physiopathes, le diagnostic clinique par clinique, les diagnostics différentiels parce que souvent, c'est des douleurs pélvienne, douleurs pévienne.

Il y a beaucoup de diagnostics qu'on doit évoquer avant de retenir une maladie inflammatoire du pelvis. Donc, en clinique, complications qui font la gravité de ce tableau. Ce sont les complications, il faut absolument faire le tout pour éviter ces complications.

Déjà, pour vous donner un petit exemple, une petite représentation, les trompes, ce sont des organes destinés à recueillir l'oeuf fécondé, à transporter le spermatozoïde à transporter le gamète après avoir fécondé. Donc, c'est un organe qui est très mobile. Sa fonction est due à sa mobilité.

Si jamais il perd ce caractère de mobilité, de souplesse, sa fonction va être perturbée. Donc, il y a un risque de stérilité. S'il n'y a pas de stérilité, même après grossesse, il risque de faire une grossesse extra-utérine.

Donc, la trompe, c'est comme du papier cigare. S'il s'infecte, même avec traitement rarement, la trompe reprend la forme qu'il avait avant d'être infecté. Donc, les trompes, c'est vraiment des tubes qui sont très fins, très souples, très mobiles.

Ils ne doivent pas s'infecter. S'ils s'infectent, il va y avoir des séquelles. C'est pour l'intérêt de la prévention.

Donc, les complications, on va parler du traitement, on va beaucoup parler du traitement et on va conclure par la suite. La définition de la maladie inflammatoire du pelvis, c'est une infection des trompes, mais pas que. Des trompes et des organes de reproduction de la cavité pélvienne, c'est-à-dire de l'envers, de l'utérus, de la cavité utérine, tout ça, ça fait partie, ça entre dans le cadre de cette maladie inflammatoire du pelvis.

Est-ce que c'est OK pour la définition ? C'est une maladie inflammatoire du pelvis. Vous pouvez l'appeler salpingite aiguë. Les francophones continuent à l'appeler salpingite aiguë.

Infection génitale haute parce qu'on ne va pas parler des infections génitales basses. Normalement, c'est le cours de sémiologie de deuxième année dans l'Ellacorée qu'on a parlé des vulvo-vaginites, des vaginites, des cervicites, des exocervicites. Ça, c'est les infections génitales basses.

Maintenant, on va parler de ce qui est normalement, de ce qui ne doit pas être infecté, qui est stérile. D'accord, et souvent, infections hautes, souvent les secondaires à un truc d'infection qui est basse et qui a sanctionné. Donc, définition conséquences graves, stérilité, on parle de stérilité tuber dans les stérilités.

Dans la majorité des cas, c'est dû à un problème tuber, avoir des stérilités hormonales. Mais souvent, ce sont les stérilités tuber qui sont la conséquence d'une maladie inflammatoire du pelvis. Donc, stérilité tuber, qui sont des stérilités mécaniques.

C'est un problème de perméabilité de la trompe ou bien de perte de la fonction de la trompe. Je vous rappelle que c'est mobile, il y a un péristaltisme, il y a des cils vibratiles qui doivent rester intacts. Si jamais il y a une infection, tout ça va être perturbé.

Parfois, la trompe est perméable, mais elle n'arrive pas à transporter. On fait une hystérosalpingographie, c'est l'examen radiologique qui permet d'explorer, de pacifier les trompes pour voir est-ce qu'elles sont perméables ou non. Il y a d'autres tests qu'on peut faire, mais souvent, dans le cadre d'une infertilité, pour retenir ou exclure une cause tuber, on demande une hystéro, c'est-à-dire l'utérus, et on injecte un salpingo, c'est-à-dire les trompes, hystérosalpingographie.

On injecte un produit de contraste par voie cervicale et on fait des clichés radiologiques. On suit le passage du tuber. Parfois, il y a un blocage, on parle d'imperméabilité du tuber.

Parfois, il y a un passage, mais il y a des anomalies tuber. C'est le cas des phimosis ou bien des hydrosalpinges qu'on peut voir dans ces images-là. Donc, on peut avoir des abcès, lorsque l'infection se collecte, soit au niveau du cul-sac de Douglas, soit au niveau de la trompe.

Ça constitue un abcès qui va répondre à toutes les règles du traitement d'un abcès, c'est-à-dire le traitement médical parfois ne suffit pas, il faut faire un drainage chirurgical. Donc, les douleurs pulvérisées, même après guérison, certaines femmes gardent des douleurs. Les douleurs chroniques, parfois très invalidantes.

Alors, c'est une pathologie qui est très fréquente, qui est grave, d'autant plus grave qu'il intéresse les femmes très jeunes. Donc, les premières activités sexuelles sont surtout des femmes jeunes, qui est le facteur de risque de faire cette maladie inflammatoire du péné. Donc, souvent suite à une infection génitale basse, comme on a dit tout à l'heure, sexuellement transmissible.

Ça va, il y a quelques questions? Non? On va jeter un coup d'œil sur la discussion. Rien, apparemment. Je ne sais pas comment défiler, ni les flèches, ni la souris, ni ma télécommande.

Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Je ne sais pas comment faire. Donc, ces infections sexuellement transmissibles, les cervicites et les urétrites aclamidia trachomatis sont actuellement en augmentation. Comme vous savez que les infections sexuellement transmissibles, avec la libération des mœurs, sont vraiment en nette augmentation, en particulier chez les femmes de moins de 25 ans.

Alors, les cervicites aclamidia, les cervicites, c'est-à-dire l'infection du col. On peut avoir des endocervicites, ça fait partie du haut appareil, comme on peut avoir des exocervicites. Rappelez-

vous le col, il y a l'endocole qui est à l'intérieur, il y a l'exocole et il y a l'ostium cervical qui c'est parlé de.

L'épithélium de l'exocole, c'est un épithélium pavimenteux puristratifié. Et l'épithélium de l'endocole, c'est un épithélium qui est cubique et qui rejoint comme un épithélium glandulaire. Et il y a la glaire cervicale qui est sécrétée par l'épithélium de l'endocole.

Et c'est comptabilisé parmi les infections. Pour les endocervicites, rapidement, on va avoir une endométrite par continuité. Rapidement, on va avoir une sépingite.

Et rapidement, on va contaminer le reste du pelvis. Ce qui va entraîner une maladie inflammatoire du pelvis. Pour les cervicites aclamidiac, c'est un germe qui donne peu de signes.

Mais qui est très agressif. Souvent, les infections aclamidiac sont asymptomatiques. Mais sur le plan pathologique, il y a beaucoup d'inflammations, beaucoup d'adhérence.

Donc, c'est un germe qui est peu bruyant, mais qui est très agressif. Pour les érythrites aclamidiac, pour les alpagites aclamidiac, pour les maladies inflammatoires du pelvis du aco-aclamidiac. C'est posé symptomatique.

On a rarement le tableau typique. On a rarement tous les signes. Souvent, c'est découvert au cours du bilan d'autre chose, d'une stérilité.

Mais sur le plan imagerie, sur le plan histologique, pathologique, on va trouver beaucoup de lésions inflammatoires. Au contraire, le gonocoque, c'est une très bonne comparaison. Le gonocoque, ça donne beaucoup de signes.

Chez l'homme, c'est l'érythrite, c'est la chaude pisse. Ça donne beaucoup de signes. C'est très douloureux, mais qui guérit facilement et sans séquelles.

Le gonocoque, il est très bruyant, mais il est gentil. Alors que le clamidia, il est peu symptomatique, mais il est plus grave. Et ça nécessite plus... Le gonocoque, on peut faire un traitement minute.

Alors que le clamidia, il faut au moins 14 jours de traitement. Sinon trois semaines, sinon un mois. Il faut faire cette distinction-là.

C'est important. Les services de clamidia sont asymptomatiques dans 70% des cas. Les cinq cliniques sont le plus souvent peu intenses et trempées.

Le clamidia, ça peut atteindre les articulations. Ça peut atteindre les conjonctivites. Il y a beaucoup d'organes qui peuvent être atteints par le clamidia.

Ça rend le diagnostic difficile. Il y a même certaines infections qui commencent au niveau du pelvis et qui vont s'étendre vers le foie. C'est ce qu'on appelle la péréhépatite de Fitzhugh-Curtis.

On va le voir. C'est une infection clamidienne. Souvent, on la découvre pourtuitement parce qu'on fait de plus en plus beaucoup de cellulose.

Et quand on trouve des adhérences entre la capsule de glissons du foie avec le pelvis, on va avoir des adhérences. Des fosses membranes, il y a des adhérences. C'est sûr que cette femme-là a fait dans les antécédents une clamidienne, une infection génitale haute par claudia.

Donc, ça s'est passé inaperçu et s'est découvert pour autre chose. Ce qui peut expliquer certaines douleurs au niveau de l'hippocampe due à une maladie inflammatoire du pelvis. Ce qui peut parfois tromper le diagnostic, rendre le diagnostic difficile.

Alors, le claudia, il est souvent asymptomatique, mais il est très agressif. Cette pathologie est fréquente, est sous-estimée, est maltraitée du fait parfois de difficultés diagnostiques. Qui va faire une infection génitale haute? Donc, dans l'interrogatoire, lorsqu'on a une suspicion, il faut chercher ces signes-là, ces facteurs de risque.

Souvent, c'est des femmes jeunes, peut-être parce qu'elles ont une activité sexuelle supérieure aux femmes âgées, peut-être parce qu'elles ont beaucoup de partenaires multiples. Il y a plus de partenaires multiples à cet âge-là, peut-être. Mais les statistiques le montrent que l'âge jeune, c'est un facteur de risque.

La précocité et la multiplicité des partenaires sexuels, c'est logique. Si on l'interrogatoire, la femme rapporte qu'elle a eu deux ou plus partenaires par an. C'est un profil à risque de faire lorsque là, une de leurs pilules vient et qu'elle a ce contexte-là, on va penser, en cherchant les autres éléments, on va penser à une infection génitale haute.

Le bas niveau socio-économique, bien sûr, le bas niveau socio-économique, il est très frappant. Il faut moins d'attention, moins de préservatifs, moins de tests, de dépistage des partenaires pour voir s'ils sont infectés ou non. Donc, le bas niveau socio-économique est également un facteur de risque qu'on doit rechercher.

Bien sûr, les antécédents d'IST. Dès qu'une femme a une infection génitale, c'est une femme qui risque de récidiver. Donc, le risque de la récidive, on va voir, dans les complications à long terme, c'est la récidive.

On va toujours parler de récidive. S'il n'est pas bien traité ou bien s'il est réinfecté, il va faire une autre infection. Donc, les antécédents d'IST, bien sûr, s'il a eu, dans les deux semaines qui ont précédé, ce qu'il a maintenant, un geste endo-utérin, c'est-à-dire un curtage ou bien une insertion d'un dispositif intra-utérin.

C'est un geste endo-utérin. Il fait un tableau de fièvre avec de l'eau péloenne. On va faire le lien et dire que c'est une infection génitale secondaire ou compliquant, un geste endo-utérin.

D'où le réflexe qu'on fait toujours. Avant de faire un geste endo-utérin, il faut voir si la femme a une infection génitale basse. S'il a une infection génitale basse, le geste endo-utérin est contre-indiqué.

C'est-à-dire que si on veut faire un DIU, un dispositif intra-utérin, on spécule que lorsque le col est rouge ou bien lorsqu'il y a des sécrétions, des locaux répathologiques, on ne peut pas faire ça, le dispositif intra-utérin, sur un col qui est infecté. C'est l'infection génitale haute à cause sûre. Donc, on traite.

On vérifie que le traitement a marché et qu'il n'y a plus d'infection. C'est à ce moment-là qu'on fait ces gestes endo-utérins. Donc, les gestes endo-utérins, lorsqu'il y a une infection génitale basse, ils sont contre-indiqués.

Ça fait partie de la prévention de ces infections génitales hautes. Donc, toutes manœuvres endo-utérines, le DIU, dans les six semaines qui suivent la pause, jusqu'à six semaines, c'est le DIU qui est responsable de l'infection. Par contre, un DIU qui est déjà en place, ça, il faut le comprendre.

C'est ce qui a changé par rapport au cours de l'année dernière. Une femme qui a un DIU, le DIU, ce n'est pas un facteur de risque de faire une infection. C'est sa pause et les six semaines qui suivent la pause qui sont un facteur favorisant.

Lorsqu'on a dépassé les six semaines, une femme qui a un DIU depuis deux ou trois ans et qui fait une infection génitale haute, on ne va pas penser au DIU et le retirer. Parfois, même le retrait n'est pas conseillé. On traite et on suit.

S'il n'y a pas de complication, ce n'est pas la pelle de le retirer. Ça, c'est les choses qui sont nouvelles. Avant, dès que la femme a une infection génitale haute, s'il a un DIU, on le retire.

Maintenant, on le retire que s'il vient d'être posé ou bien lorsqu'il y a une complication haute qui va maintenir l'infection. Dans les six semaines suivant la pause, le risque de faire une infection, c'est 1 %. Ce n'est pas un grand risque. Bien sûr, on respecte les contre-indications.

En revanche, le port d'un DIU n'est pas un facteur de risque d'infection génitale haute. C'est ce que je viens de dire. Ça va? Des questions? Un peu de physiopathes.

Comme on l'a dit, les transmissions sexuelles, c'est dans 85 % des cas. La majorité des cas, c'est dû à un rapport sexuel, une transmission sexuelle. D'où le dépistage, d'où le préservatif, d'où le dépistage des infections sexuelles transmissibles.

Les causes iatrogènes, c'est-à-dire manœuvres endo-utérines, seulement 15 % des cas. Parfois, c'est une infection de voisinage du pelvis, c'est-à-dire une appendicite qui a infecté l'appareil génital, ou bien une sigmoïdite qui n'est pas très fréquente dans notre contexte, qui peut infecter

l'appareil génital. C'est exceptionnel.

Les principaux germes incriminés dans les transmissions sexuelles, c'est le chlamydia et le gonocoque. Surtout le chlamydia. Pour les gestes endo-utérins, gestes invasifs endo-utérins à l'origine d'une infection ascendante par des agents infectieux provenant de la flore vaginale et périnéale.

Le périnée et le vagin, ce n'est pas des sites qui sont stérilisés. Il y a une flore commensale qui existe à ce niveau-là et qui peut être, dans certaines situations, lorsque la femme a un TAR, un diabète ou autre chose, ces germes-là qui étaient habituels, non pathologiques, deviennent pathologiques chez elle. Dans ces cas-là.

Provenant de la flore vaginale et périnéale, parmi ces gestes endo-utérins, une aspiration endo-utérine, quand est-ce qu'on fait une aspiration endo-utérine? Lorsqu'on va faire un avortement, lorsque la femme a une fausse couche à l'avortement, si la grossesse elle est jeune, la simple aspiration permet de vider l'utérus. Donc, s'il y a une infection, si la femme ne se sent pas beaucoup, on donne des antibiotiques pendant 48 heures pour refroidir l'infection et on fait ces gestes-là. S'il n'y a pas d'infection, on le fait.

Mais ça fait partie des facteurs de risque d'une infection génitale haute. Donc, hystéroscopie, caméra introduite à travers le corps pour explorer quoi? L'endomètre. Après l'hystéroscope.

On le fait lorsqu'on suspecte un saignement d'origine endométriale. Donc, l'hystéroscopie, également s'il y a une infection, on risque d'entraîner une maladie inflammatoire du pelvis par ce geste. C'est un geste endo-utérin.

Donc, l'hystéroscope, l'hystérosopérogaphie, l'imagé dont on a parlé tout à l'heure, l'hystérosopérogaphie, pose de dispositifs intra-utérins, stérilisés, la pose de stérilisés. Donc, parmi les contre-indications des gestes endo-utérins, surtout, on essaie de les faire toujours en première partie du cycle. Pourquoi? On est sûr que la femme n'est pas enceinte parce que le geste endo-utérin, on le fait.

Par exemple, un DIU, vous le placez chez une femme qui est enceinte, vous allez entraîner un avortement. Donc, c'est pour cela qu'on préfère que la femme aille d'avoir ses règles. Si on a un doute, on demande au Béta CG.

Et bien sûr, s'il y a une infection, on ne fait pas de geste endo-utérin. On risque d'entraîner une maladie inflammatoire du pelvis avec toutes les complications qui peuvent être liées. Concernant les gestes endo-utérins, qui constituent 15% de la maladie inflammatoire du pelvis, transmission par continuité, c'est les appendicites et les sigmoïdes.

Un schéma qui montre bien un petit peu la physiopathie. On passe de cervicite, infection juste du col, il y a l'exocol et l'endocol. Si on fait un geste endo-utérin, bien lors des rapports sexuels,

STD, Sexual Transmitted Disease, cause une bactérie, may enter vagina with semen.

L'infection peut entrer avec le liquide séminal au niveau de l'utérus. Entraîner une endométrite, c'est l'endomètre, l'utérus, bactérielle may pass through cervix and enter uterus. Après l'endomètre, elle va passer au niveau des salpingitis, oophoritis, ovaritis, tubo ovarian abscess, un abcès tubo ovarien, ça peut entraîner ça lorsqu'il y a un passage à ce niveau-là.

Et plus loin, lorsqu'il y a une altération de défense de la femme, ça peut entraîner une pelvipéritonite. La pelvipéritonite est localisée au pelvis. Si on ne fait rien, ça va donner la pelvipéritonite généralisée.

Qui est plus grave, la pelvipéritonite ou bien la pelvipéritonite? La pelvipéritonite est beaucoup plus grave. La pelvipéritonite, c'est juste localisé au pelvis. La pelvipéritonite ou bien la pelvipéritonite généralisée, c'est plus loin.

Mais rarement on arrive à ce niveau-là si on fait le diagnostic et on commence le traitement. Donc ça, c'est le tableau qui montre les étapes de l'infection génitale haute. Voilà les instruments qu'on utilise lors des gestes endo-utérins.

Ça, c'est quoi? C'est un hystéromètre. Ça permet de mesurer la longueur de la cavité utérine afin de... Même si on fait l'échographie, on peut avoir une estimation indirecte, mais lorsqu'on fait un geste, on fait l'hystéromètre d'abord pour mesurer la profondeur de la cavité utérine afin d'utiliser par la suite des curettes. Cet instrument-là et celui-là.

Donc on utilise ces deux curettes pour... Bien sûr, lorsqu'il est avancé, il est un petit peu avancé. Lorsqu'il n'est pas avancé, on utilise malheureusement, je ne l'ai pas, l'aspiration. Il y a des curettes qui sont perforées à l'extrémité et on pratique une... On a un mécanisme qui entraîne une pression négative qui permet d'aspirer.

Et on peut aspirer au niveau des 4 facettes de l'utérus pour l'évacuer. Ça suppose que la grossesse est très jeune, qui n'est pas avancée, et on peut se contenter d'une aspiration. Si la grossesse est plus âgée, bien lorsque l'aspiration n'arrive pas à vider la cavité utérine, on utilise des curettes.

Bien sûr, il y a une curette fenêtrée et une curette qui est mousse. À votre avis, laquelle est plus agressive? Bien sûr, la fenêtrée, elle est réputée être plus agressive. En termes de quoi? Lorsqu'on fait un curetage avec cette curette-là, quel est le risque après le curetage? Le risque de signifier, le risque d'avoir des brides et les brides entraînent beaucoup de complications par la suite.

Dans les gestes, ça en sort un petit peu du court, mais il faut que l'on sache qu'on peut utiliser des curettes. L'idéal, c'est l'aspiration. Si on n'arrive pas à aspirer, on fait la curette mousse, bien sûr, gentiment.

Si parfois la curette mousse n'arrive pas, on utilise la curette fenêtrée. Ça, c'est quoi? Qui peut me dire ça, c'est quoi? C'est les instruments avec lesquels on dilate le col. C'est ce qu'on appelle des bougies.

Des bougies. Il y a des numéros 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, enfin, pas jusqu'à 20. Et pour pouvoir introduire, bien sûr, ces curettes-là, si le col est fermé, vous ne pouvez pas passer.

Il faut dilater numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à numéro 6, minimum, pour pouvoir faire passer. Ça, c'est la direction du col. Ça, c'est des choses que vous allez voir par la suite.

Mais il faut que j'en parle. Ce sont des gestes en droit de terrain, la dilatation. Avant de faire une évacuation d'une fausse couche, si le col est fermé, il faut le dilater avec les bougies.

Ce qu'on appelle les bougies de égard. H-E-G-A-R. Elles sont numérotées.

On entre avec le numéro 1, puis on passe au 2, au 3, et ça permet d'avoir une dilatation douce du col utérin. Quel est le risque de la dilatation? Il y a un risque d'infection si jamais il y a une infection. Quel est l'autre risque? Vous allez le voir durant vos cours de gynécologie.

La baillance cervico-osmique. Très bien. On risque d'entraîner une baillance cervico-osmique si on dilate plus qu'il le faut.

Parce que le col doit être compétent, doit être fermé lorsque la femme est enceinte. Si jamais le col est un petit peu perméable, l'oeuf va être en contact avec le milieu extérieur et donc il risque d'avoir une infection de l'oeuf et une évacuation de l'oeuf avant le terme. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses.

Ça, c'est les bougies. Vous voyez, c'est bien de l'emmener parce que... Ça, c'est quoi? Le stérilet, vous le connaissez. C'est un stérilet au cuivre parce qu'il y a du cuivre ici.

Cet instrument, ce n'est pas un instrument qui rentre à l'intérieur de l'utérus mais c'est un instrument qui permet de tenir le col parce que le col, si vous ne le tenez pas, vous ne pouvez pas faire de gestes à l'intérieur. Il faut le tenir avec une main. On le pince avec cet instrument-là afin de pouvoir dilater au début et introduire les curettes.

Donc, je passe rapidement. Donc, on a vu la définition. On a vu les facteurs de risque.

On a vu un petit peu de physiopathologie sur les infections basses qui montent vers le haut, qui peuvent avoir différents degrés de gravité. On a parlé de germes qui peuvent être responsables. En premier, le chlamydia.

Après, le golocoque. Après, les germes qui sont dus à la flore vaginale, notamment les *chirichia coli* ou bien les entérobactéries ou bien les anérobis parfois. Donc, on a vu tout ça en tant que physiopathe.

Maintenant, on va passer au diagnostic. Alors, déjà, puisque c'est le chlamydia, c'est un germe qui est très trompeur, qui est process symptomatique et qui permet de faire retarder le diagnostic. Donc, difficile.

Le tableau clinique souvent incomplet est trompeur et les formes asymptomatiques sont malheureusement très fréquentes qui retardent le diagnostic. Le diagnostic de certitude, ce n'est pas le prélèvement vaginal qui va dire que c'est une infection génétale. Il va aider au diagnostic, mais ce n'est pas lui qui va le dire.

Donc, le prélèvement vaginal, lorsqu'on trouve un germe, on va dire que c'est une cervicite parce qu'on l'a prélevé au niveau du col. Mais il ne va pas vous dire que c'est une salpingite. Pour dire que c'est une salpingite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller jusqu'au trempé, prélever au niveau du trempé et trouver le germe au niveau du trempé.

Alors que si on ne trouve le germe qu'au niveau du prélèvement vaginal, c'est qu'une vaginite ou bien une cervicite. Ça peut aider lorsqu'il y a une douleur à la mobilisation, lorsqu'il y a de la fièvre, lorsqu'il y a de la glaire et lorsqu'il y a de l'infection, ça aide. Mais la confirmation, la confirmation, c'est la celluloscopie avec le prélèvement au niveau du pelvis.

D'accord? Est-ce qu'on a toujours besoin de cellules? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Souvent, on n'a pas besoin de cellules pour traiter. On peut avoir l'interrogatoire, rechercher les facteurs de risque qu'on voit, voir les cellules fonctionnelles qu'on va voir, qui sont presque pathogonomiques parfois lorsqu'ils sont présents d'une infection génitale.

Avant de commencer le traitement, avant d'atteindre le résultat du prélèvement. Parfois, ils sont passés même de la cellulose. Donc, c'est des mots-clés dans ce cours-là.

La cellulose, les infections génitales hautes, les infections génitales basses, la flore vaginale, le colococ, le chlamydia, ce sont des mots-clés. Dès que vous parlez de ça, il faut toujours faire ressentir les gestes endoéthérins, les maladies sexuellement transmissibles. Ce sont des mots-clés qu'il faut toujours avoir lorsque vous voulez traiter ce cours-là.

Alors, c'est quoi le tableau typique malheureusement rare? Si on a de la chance, si on va voir le tableau typique, c'est le tableau typique, un syndrome infectieux franc, c'est-à-dire une fièvre supérieure à 38,5. Des douleurs pélvienues. Des locorées pérurantes et nos yeux à ventes.

Donc ça, c'est l'interrogatoire et l'examen clinique. Et une douleur, c'est-à-dire à l'examen clinique, à la mobilisation utérine. Lorsque vous avez ce tableau-là, c'est pathognomonique.

On n'a pas besoin d'attendre le prélèvement. On fait le prélèvement juste pour la suite, mais on doit commencer le prélèvement. C'est le tableau typique, c'est presque pathognomonique.

Fièvre, syndrome fibril, douleurs pélvienues, locorées fétides, locorées pérurantes ou fétides, et

douleurs très importantes, douleurs à la mobilisation de l'utérus. Le toucher vaginal ou bien le spiculum, il est douloureux. Même si on arrive à le faire, c'est très douloureux et on déclenche des douleurs à la mobilisation soit de l'utérus, soit des annexes.

Ça, c'est un tableau d'une infection génitale haute. Il faut commencer le traitement de manière adaptée. Donc, ça, c'est le tableau typique.

Malheureusement, ce n'est pas le plus fréquent. Comme on l'a vu, c'est un tableau souvent, c'est post-symptomatique ou bien asymptomatique. Les formes post-symptomatiques sont les plus fréquentes.

Du fait du chlamydia, je répète encore ça, le chlamydia, il est silencieux, mais il est très agressif. Il est silencieux, il fait retarder le diagnostic, mais il est très agressif. Il est très virulent, très agressif.

Les formes post-symptomatiques sont découvertes souvent dans un bilan d'infertilité. On cherche le bilan d'infertilité, on fait un prélèvement, on trouve qu'il y a beaucoup de poules nucléaires ou bien lorsqu'on fait des prélèvements, on trouve qu'ils sont positifs. Vu que ce n'est pas la douleur P, bien la fièvre, la douleur à l'immobilisation qui a amené à nous pousser à faire le bilan.

Alors, qu'est-ce qui va aider? Notre interrogatoire, lorsqu'on suspecte une infection agitante, on recherche d'abord les facteurs de risque, notamment les antécédents médicaux chirurgicaux, hygiénico-cytriaux, s'il a fait des infections dans le passé, s'il a fait un gestion de l'utérin, s'il a des facteurs de risque, le jeune âge, l'antécédent d'infection, les partenaires multiples, la précursité des rapports sexuels, tout ça, c'est en faveur, ça doit interpeller vers l'infection génitale. Ou bien la notion de gestion de l'utérin, récent, souligné bien récent, dans un dispositif intra-utérin, interruption pendant le process, stéroscopie, stéréoscopographie, révision utérine, tout ça, ce sont des gestions de l'utérin. Donc, on doit rechercher ces éléments-là à l'interrogatoire.

Plus ces éléments sont fonctionnels, on va chercher la douleur, la hémorragie, les locorées. Donc, les éléments fonctionnels, les douleurs, qui sont heureusement parfois les seuls qui sont présents. Ils sont plus que la fièvre ou autre chose.

90% des cas, on peut trouver des douleurs. Les douleurs, ça peut varier. Des petites douleurs, ou vraiment douleurs très lancinantes, très intenses.

On précise la localisation. Souvent, si la femme a des douleurs, on essaie de lui dire où a commencé la douleur. Parfois, la femme vous dit que ça a commencé à droite ou bien à gauche, et après, ça s'est généralisé.

Donc, on demande bien, si on pense à l'infection, il faut essayer de remonter avec la femme le siège de la douleur. Souvent, ça a commencé au niveau unilatéral et s'est bilatéralisé par la suite.

Donc, l'horaire de la douleur, quand est-ce que l'intensité, et bien sûr, les éventuelles irradiations.

Irradiation, c'est pour les diagnostics différentiels. Si ça irradie vers le haut, c'est des colic néphéritiques ou bien ça va vers le bas, c'est autre chose. Donc, c'est en fonction du diagnostic différentiel ou bien l'inverse.

Alors, les douleurs dans 90 % des cas, donc c'est souvent eux qui sont présents. Les localisées pathologiques dans 50 % des cas, donc même, parfois, en examen, on trouve que les localisées ne sont pas anormales. Ce qui encore peut tromper le diagnostic, c'est d'avoir des saignements et l'infection.

Le saignement, qu'est-ce qu'il a à faire ici? Souvent, quand on a un saignement, on pense à autre chose. On pense à un fibroma, un cancer, à une endométriose. Là, l'infection, dans 80 % des cas, s'accompagne avec le saignement.

Bien sûr, c'est des petits saignements. L'inflammation de l'endomètre, ça fait saigner. L'inflammation de l'endomètre ou bien de la trompe, on peut avoir des petits saignements.

Ce sont des météorologiques qui n'ont rien à voir avec la règle. Donc, c'est les formes qu'on appelait les salpingites hémorragiques. C'est autre chose.

Bien sûr, on peut trouver des signes urinaires. Dans ce cas-là, on va penser plutôt à un chlamydia, notamment une urétrite. Bien sûr, quand on pense à une infection génitale, il faut toujours demander ce que le partenaire a des symptômes.

Toujours. Il faut faire un bilan chez le partenaire. Il faut traiter le partenaire, si la femme confirme chez elle qu'il y a une infection.

Ce sont des réflexes. L'infection, ça s'attrape à deux. 85 % du cas, c'est sexuellement transmissible.

Alors, on a vu l'interrogatoire pour rappeler les signes fonctionnels. Maintenant, les signes généraux. La température, dans 55 % des cas, on a plus de douleurs que la température.

Dans 90 % des cas, la température, une fois sur deux, est absente. L'absence de température n'élimine pas le diagnostic. S'il y a une douleur, même s'il n'y a pas de température, il faut que je continue à chercher si ce n'est pas une infection.

La palpation exacerbe la douleur hypogastrique au milieu, avec une défense dans 13 % des cas. Dans 13 % des cas, une femme sur trois a une défense. Rechercher une douleur d'hypocondre dans le cadre du syndrome de FITZ, parce qu'il y a des adhérences entre le pelvis et la capsule de glissons du foie.

Même s'il y a une douleur, vous ne devez pas éliminer le diagnostic, sachant que ce syndrome,

on peut avoir de la douleur au niveau de ce syndrome. Donc les signes généraux, la palpation, la défense dans 13 % des cas, le spéculum, qui est l'examen qui est très important. On ne peut pas dire qu'on a pris une charge, une infection génitaloïde, si on n'a pas fait le spéculum.

Maintenant, il y a des spéculums jetables dans tous les centres, dans toutes les pharmacies. S'il y a de la douleur, il vient. S'il rapporte des locorées, il faut voir ce qui se passe à l'intérieur.

Le spéculum, ça permet de voir et ça permet de faire des prélèvements. C'est surtout pour les prélèvements qu'il faut le faire. En essentiel, de l'examen clinique, ils recherchent une locorée typiquement purulente, une oseille à bandes, dans les cas extrêmes, une cervicite, un col qui est rouge, inflammée.

Parfois, la glaire est juste louche. Il est un petit peu clair, mais il est un petit peu louche. Ça, c'est dans les cas un petit peu moins typiques.

Parfois, on voit un saignement d'origine de l'utérin dans le cadre des métrorragies. Ce spéculum-là permet de réaliser des prélèvements pour la bactériologie. Réalisation de prélèvements pour la bactériologie.

Ce sont des prélèvements vaginaux et de l'endocolle. On fait des prélèvements au niveau du cul-sac de Douglas et au niveau du col. À la recherche de germes intras et extracellulaires, bien sûr, le chlamydia est un germe extracellulaire.

Bien sûr, pour trouver le chlamydia, ce n'est pas juste le fait d'effleurer le col pour trouver le chlamydia. Le chlamydia est un germe intracellulaire. Il faut un petit peu pousser pour racler un petit peu l'épithélium superficiel pour rechercher le chlamydia.

Souvent, maintenant, le chlamydia, on le recherche par PCR. Tellement, il est difficile à mettre en évidence. Donc, palpation abdominale, spéculum, le toucher vaginal, douloureux, douleur à l'âme, blessure de l'utérus, on la cherche.

Si on a des douleurs pélviennes, de la fièvre, des leucorrhéphytides et douleur à l'âme, blessure de l'utérus, je vous rappelle, c'est presque pathogonomique d'une infection génitale haute. Parfois, on trouve une douleur annexielle, provoquée, on fait le toucher et on touche les cul-de-sac. Parfois, vous avez plus une douleur d'un côté que de l'autre.

Parfois, on trouve juste un petit empattement. Ce n'est pas une masse, mais on a l'impression que ce n'est pas libre. C'est ça, l'empattement.

L'empattement, ce n'est pas une masse, mais on trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas libre. Normalement, au toucher vaginal, vous touchez les cul-de-sac sans problème.

Vous arrivez à palper avec la main abdominale et faire mobiliser l'utérus sans douleur, sans vraie

douleur, si vous le faites gentiment. Mais s'il y a une infection, vraiment, le toucher, il est douloureux. Et si encore vous faites mobiliser l'utérus, c'est encore plus douloureux.

L'interrogatoire, l'examen clinique. Voilà quelques images de col. Un col sans glaire, un col avec la glaire qui est rouge, là c'est rose.

Il faut faire beaucoup de spéculation pour voir, pour commencer à faire la distinction entre un col qui est rose avec une glaire qui est claire, limpide, qui est normale. Par rapport aux cols qui sont rouges, ce n'est pas facilement en contact avec un écoulement infecté, avec une glaire ou bien des cols qui sont grisâtres, jaunâtres, fétides. Donc, il faut faire beaucoup d'exams spéculants pour pouvoir faire la différence entre un col qui n'est pas infecté, par rapport à un col qui est infecté.

Les infections vastes, est-ce que c'est du trichomonas, est-ce que c'est du chlamydia, est-ce que c'est du gonococ, chaque infection a ses propres caractéristiques. Grisâtres, verdâtres, jaunâtres. Tout ça, ça permet même de prédire le germe qu'on va trouver.

C'est un col qui est infecté, normal. Là, c'est un col normal, c'est rose, avec la glaire qui est translucide. Sur la glaire, vous savez que c'est une femme en période d'activité génitale.

La glaire, aux premières parties du cycle, ce n'est pas la même glaire au milieu du cycle. Ce n'est pas la même glaire à la fin du cycle. La glaire, elle est maximale en période ovulatoire, à côté de l'ovulation.

Ça, vous le savez. L'estrogène, la glaire, c'est sous la dépendance des oestrogènes. Les oestrogènes sont maximales à l'approche de l'ovulation.

C'est là où les glandes endocervicales du col créent plus de glandes. Bien sûr, c'est pour faciliter l'entrée des spermatozoïdes à l'intérieur du tuyau pour avoir des grossesses. Tout ça, c'est fait pour avoir des grossesses.

Bien sûr, dès qu'on dépasse cette période de l'ovulation, en deuxième partie du cycle, si supposé que le spermatozoïde est entré et que la fécondation a eu lieu, la glaire devient plus lucide. Elle devient visqueuse. Elle devient un obstacle à l'entrée d'autres spermatozoïdes en deuxième partie du cycle.

Ça, vous le savez en physiologie. Même les mailles de la structure de la glaire, si on la voit au microscope électronique, au moment de l'ovulation, ce sont des mailles qui sont perméables. Juste après l'ovulation, deux jours, trois jours après l'ovulation, il coagule.

Il devient comme un bouchon. Bien sûr, lorsqu'il y a une infection, tout ça est troublé. Les cols qui sont anormaux, les cervicites aclamidia, col qui est très sale, rouge, avec des nues de vascularisation.

Vous voyez de la glaire? C'est une cervicite micropurulente, soit le colocoque, soit autre chose. Vous voyez, c'est des cols qui sont rouges, qui sont sales par rapport à ce col qui est rose, avec une glaire limpide, translucide. Si vous voyez ce col-là, ce n'est pas une infection.

Après l'interrogatoire, après l'examen clinique, tous les éléments sont importants. Bien sûr, le spéculum, le toucher vaginal, très important pour voir et pour faire des prélèvements. On passe à la biologie, qui va nous apporter des éléments pour nous aider dans le diagnostic.

L'hyperleucocytose, avec une cervique très élevée, c'est très en faveur d'une infection. Donc, mise en évidence d'un syndrome inflammatoire biologique. Ce qui est également important à connaître dans la biologie, dans le cadre de douleurs péloriennes.

Je suis une femme jeune, toutes douleurs péloriennes. Je suis une femme jeune. Bien sûr, on va penser à beaucoup de diagnostics, mais il ne faut jamais oublier la grossesse.

Il ne faut jamais oublier la grossesse. Je suis une femme jeune. Si tu ne penses pas à la grossesse.

Donc, même des gens qui sont très expérimentés peuvent passer à côté d'une GU ou bien d'une grossesse. Une GU, c'est plus grave. Parfois, on passe à une grossesse intra-utérine, jeune.

Souvent, des femmes, au début de la grossesse, elles disent qu'elles ont des douleurs péloriennes. Faire attention, toujours penser à la grossesse. Femme jeune, demander la date des dernières règles.

Ça a de la valeur lorsque la femme a des règles qui sont très régulières. Et bien sûr, si la femme prend la contraception. Ça a de la valeur.

Une fois qu'il y a des règles qui sont très irrégulières, la date des dernières règles devient secondaire et il faut demander minimum un test de grossesse. Maintenant, ce n'est pas toujours qu'on fait un prélèvement. On peut faire des tests de grossesse actuellement dans les pharmacies.

Ils sont très performants. Donc, jamais, jamais, toujours, dans les méthodologies chez la femme, dans les douleurs, dans toutes les situations, il faut penser à la grossesse. Toujours penser à la grossesse.

Ça, c'est une chose en gynécologie. Vous avez une femme, même en dehors de la gynécologie, vous êtes plémonologue, vous êtes cardiologue, dès qu'une femme rentre chez vous, elle est jeune, toujours penser à la grossesse. Le traitement que vous allez prescrire peut retentir sur la grossesse.

Le bilan que vous allez prescrire peut retentir sur la grossesse. Et en moindre doute, demander un test de grossesse. Donc, la biologie, la biologie, la biologie, les examens

avizibactériologiques.

Maintenant, on va chercher l'éthiologie. Je vous ai dit que le prélèvement, ça permet d'orienter vers l'infection génitale, mais c'est pas la certitude. La certitude, c'est quoi? C'est la série avec prélèvement.

Donc, ça permet de voir, ça permet de prélever sur le site qui est infecté. Donc, prélèvement cervico-vaginal, alors ce prélèvement-là, il y a l'examen direct, Il y a l'examen standard et il y a la PCR pour le chlamydia. Il y a la PCR pour les ciréas gonorrhées.

Maintenant, lorsqu'on fait un bilan d'infection, on demande tout ça. L'examen direct, l'examen standard, PCR pour chlamydia, PCR pour gonocoque. Maintenant, la plupart des laboratoires peuvent faire ça.

La plupart des laboratoires peuvent faire ça. Juste, il faut que le prélèvement soit... On ne fait pas de toilettes avant. Il ne faut pas le souiller avec l'Epala ou bien le Péliné.

Il faut que le prélèvement se fasse vraiment au niveau endocervical. Si on cherche le chlamydia, il faut racler. Donc, ce sont des prélèvements qui sont un peu spéciaux.

Donc, biologie, les examens à visée bactériologique, prélèvement cervico-vaginal pour l'examen direct, pour le PCR du chlamydia, pour la PCR du gonocoque et pour l'analyse bactériologique standard à la recherche de BGN, d'anaérobie ou d'autres germes. Bien sûr, s'il a des frissons, s'il a la fièvre très élevée, s'il frissonne, s'il a 39 degrés, 39,5, les hémocultures, c'est un réflexe comme dans tous les domaines de la médecine. Dès qu'il y a des frissons avec la fièvre, il faut faire des hémocultures.

Il faut toujours faire des hémocultures. On a plus de chances de trouver qu'elles sont positives lorsque la femme frissonne et il a une fièvre qui est très élevée. Bien sûr, le CBU, il est obligatoire, si l'infection vient de la base.

Chez la femme, l'appareil génital et l'appareil urinaire sont très proches. Il faut faire également le CBU et chercher ce qu'il n'y a pas de gonocoque ou bien de chlamydia. Donc, bien sûr, penser aux prélèvements chez le partenaire.

Si le partenaire présente également des symptômes, il faut lui faire des prélèvements. On va voir quels sont les prélèvements qu'on va faire pour le dépistage des IST chez le partenaire ou bien chez les femmes qui n'ont pas encore fait d'infection génitale haute. Alors, c'est quoi le bilan de l'IST ? C'est quoi ? Vous demandez un bilan d'IST, qu'est-ce que vous allez faire dans votre demande ? Bilan d'IST, ça peut dire beaucoup de choses.

Mais qu'est-ce que je dois demander ? L'HIV, bien sûr, si la femme est d'accord. L'HIV, vous n'êtes pas obligé de demander. Vous n'avez pas le droit de demander l'HIV sans que la femme consent.

Il doit consentir. En général, toutes les femmes, en général, vous allez lui dire que je vais demander l'HIV. Ils te disent oui, oui, demande-le, en général.

Mais il ne faut pas le demander sans aviser la femme. Bien sûr, l'HIV, la syphilis, l'hépatite, en fonction du contexte, il y a des métiers à risque. Il y a les médecins, c'est un métier à risque, l'hépatite, surtout les spécifiques qui travaillent avec beaucoup de sang, les chirurgiens.

Donc, c'est ça le bilan d'IST complet qu'on va demander. Sérologie HIV, après-accord, syphilis, hépatite, B, plus ou moins C, selon le contexte. Ça, on le demande.

Alors, l'imagerie, qu'est-ce qui peut nous aider lorsqu'on suspecte une infection génitale haute, l'imagerie? Premier examen en gynécologie qu'on ne devrait jamais oublier, c'est l'échographie. En gynéco, l'échographie, c'est le prolongement de l'examen clinique. Ça fait partie.

Il y a même des... Maintenant, même... Je fais l'examen, je termine avec l'échographie. C'est un prolongement de l'examen clinique. Là, on l'appelle l'examen paraclinique, mais en général, en gynécologie, en obstétrique, c'est le prolongement.

C'est comme de l'examen clinique. Tellement c'est important, c'est invasif. On peut le faire le nombre de fois qu'on veut.

Ça donne beaucoup de renseignements en matière d'infection génitale haute. Qu'est-ce qu'on cherche? Pas la salpingite, simple, qui n'est pas compliquée. On cherche les complications.

Souvent, lorsqu'il n'y a pas de complications, l'échographie, elle est normale. Une échographie normale n'élimine pas une infection génitale haute. Par contre, quand je vois un abcès, c'est une infection génitale compliquée d'en abcer.

Compliqué. Lorsque je vois un abcès au niveau du cul-de-sac de Douglas, c'est une infection génitale haute compliquée d'en abcer du cul-de-sac de Douglas. Donc, c'est ça l'échographie.

Elle est systématique parce que c'est le prolongement de l'examen clinique, toujours demandé en gynécologie. Qu'est-ce qu'on recherche? Une masse latérale utérine. Une masse latérale utérine MLU Afina, Afina, Xmakamla, Xmakamla Afina, j'aime pas les abréviations mais dans les diapositifs on est obligé de sauf si bien sûr c'est des abréviations qui sont connues par tout le monde.

Si quelqu'un va les oublier, j'écris tout, tout le terme. Même masse latérale, maintenant tous les gynécologues écrivent une masse latérale utérine dans leur rapport, dans leur compte rendu d'échographie. Donc, échographie, recherchons une masse latérale utérine.

Faisons évoquer un pio-salpinx. Pio, c'est quoi? C'est le pu. Salpinx, c'est un abcès de la trempé.

C'est du pu au niveau de la trempe. C'est comme un abcès de la trempe. Pio-salpinx.

Il y a hydrosalpinx. Hydrosalpinx, c'est autre chose. C'est une trempe qui est malade, mais qui n'est pas infectée, mais qui contient une collection liquidienne.

Ça, c'est hydrosalpinx. Ce n'est pas du pu. Le pio-salpinx, même en échographie, on arrive à distinguer entre hydrosalpinx, c'est anéchogène, avec une trempe.

Normalement, la trempe n'est pas bien visible en échographie. Une trempe normale, une trempe normale, c'est 2 millimètres. Bien sûr, ça varie.

Est-ce qu'on est proximal par rapport à un touriste ou bien c'est distal? Mais rarement, on arrive à voir la trempe lorsqu'elle est normale, sauf s'il contient du liquide. Du liquide, ça peut être un hydrosalpinx. C'est anéchogène.

Anéchogène, le terme d'échographie. Il n'y a pas d'écho. S'il contient des échos fines, c'est un pio-salpinx.

C'est du liquide qui contient hétérogène. Le pio-salpinx, c'est une collection à contenu hétérogène. D'accord? D'accord? En général, l'hydrosalpinx, c'est une séquelle d'une infection, soit traitée ou non.

Par la suite, la femme a des douleurs. Quand on fait l'échographie, on trouve un aspect particulier de la trempe remplie par un liquide, peut-être droite ou gauche, ou bien bilatéral. Et on parle à ce moment-là d'images en faveur d'un hydrosalpinx.

Dans la phase aiguë, dans la douleur, on va trouver plutôt lorsqu'il y a un abcès au niveau du doublat, pardon, un abcès au niveau de la trempe, on va trouver un contenu écogène de ce liquide. Donc, bien sûr, après l'échographie, sachez qu'il faut ajouter quelque chose ici. Une échographie normale ne permet pas d'éliminer une infection génitale haute.

Ça permet d'éliminer les complications, mais ça n'élimine pas une infection génitale haute. On peut parfois s'aider d'un scanner, des TDM, abdominal pilviens. Lorsqu'on a un doute clinique, lorsque ce n'est pas très clair, il y a la douleur, mais il n'y a pas de la fièvre, il y a l'hémétroragie, le scanner peut donner des renseignements supplémentaires par rapport à l'échographie, mais ce n'est pas systématique.

Mais surtout, dans le diagnostic différentiel, ce qui n'est pas un problème urologique, ou bien un problème digestif, mais ce n'est pas systématique. L'échographie, c'est elle qui est systématique. L'échographie peut trouver une masse.

Dans ce cas-là, c'est un abcès. Comme il peut être normal dans ce cas-là, ça n'élimine pas, mais ça nous dit que c'est très probablement une infection génitale haute qui n'est pas compliquée. Très important, dans les infections génitales hautes, est-ce qu'on est dans une forme compliquée

d'abcès ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'abcès ? Le traitement n'est pas le même.

L'évolution n'est pas la même. Même le diagnostic n'est pas le même. Donc, dans la part clinique, on a parlé de la biologie.

NFS, RP, Beta-CG. On a parlé des prélèvements cervico-vaginaux, PCR, trachomonas, PCR chlamydia, examen direct, examen standard à la recherche d'autres germes. On a parlé du bilan d'IST qu'on va demander, sérologique.

On a parlé de l'imagerie. Maintenant, on va parler du test de référence qui est la celluloscopie. Ça permet de voir maladies inflammatoires du pelvis.

Il n'y a pas mieux que de voir une image. Ce n'est pas comme si on voit directement un scanner ou bien une échographie. Ça donne une image qui a toute une valeur, mais le fait de voir, de faire un pneumopéritoïne et d'aller voir les trempes.

Aucun autre examen ne peut remplacer ça dans certaines situations, dans certaines situations. La celluloscopie diagnostique n'est pas recommandée en première intention. On ne la demande pas en première intention.

C'est l'examen de référence et c'est lui qui donne la certitude, mais on ne la demande pas. Ça reste quand même un examen. Il faut une anesthésie générale, un pneumopéritoïne.

Il y a des risques. C'est pour cela qu'on le laisse que là, on va voir les indications, mais ça sera réalisé en cas d'échec. Déjà, on a commencé à parler des indications.

En cas d'échec de l'antibiothérapie probabiliste, parmi les mots clés dont j'ai parlé tout à l'heure, dans l'infection génitale haute, il y a l'antibiothérapie probabiliste. C'est un mot clé. Si vous voulez résumer ce cours là, reprenez que les mots clés.

À travers ces mots clés là, vous allez faire tout votre cours, l'antibiothérapie probabiliste, échec de l'antibiothérapie probabiliste, on commence à douter. On a donné des antibiotiques à large spectre, le tableau clinique qui normalement au 48 heures, 3 jours, si vous êtes efficace, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de symptômes. Si il reste, c'est que peut-être qu'il y a autre chose.

Dans ce cas là, il faut faire de la scéliscopie. L'antibiothérapie probabiliste, on a un cas de suspicion de complication pus alpinx ou bien pulvi-pelitoris. Quelles sont les indications de cette scéliscopie qui est l'examen idéal, mais qu'on ne doit pas demander de prélever l'intention? Les indications lorsqu'il y a un doute diagnostique.

Parfois, on a des petits symptômes, rien ne concorde, on ne veut pas lâcher la femme et les jeunes, si on la lâche, on risque de la galoper. Donc, doute diagnostique malgré une imagerie complète. Vous avez toujours un doute.

Lorsqu'il y a une présence de signe de gravité, lorsqu'il y a un abcès, il faut y aller, il faut le drainer. La meilleure façon de le drainer, c'est la scélio. Donc, doute, signe de gravité, lorsqu'il y a une connexion, ça rejoint l'abcès.

Si présence de connexion pulvienne abcédée, non accessible au drainage par panction transvaginale. Alors, dans les connexions pulviennes, ça, vous devez les connaître une fois pour toutes. Vous faites l'échographie, il y a une masse, il y a une connexion.

Vous suspectez une infection. Lorsque cette masse-là siège au niveau du cul-sac de doublat, et seulement au niveau du cul-sac de doublat, on peut y accéder par voie vaginale. Pour faire un spéculum, on voit le col, sous le col, et on va trouver un bombement.

Le cul-sac de doublat, c'est la partie supérieure, c'est le tiers supérieur de la paroi postérieure du vagin. Lorsqu'il y a une connexion pulvienne, lorsqu'il y a une connexion au niveau du cul-sac de doublat, dès le spéculum, vous allez trouver un bombement. Lorsqu'on a un bombement, il suffit d'inciser au niveau de ce bombement-là et vous avez traité la femme.

Bien sûr, avec les antibiotiques. Et vous n'avez pas besoin d'ouvrir par eau. Lorsque ce n'est pas le cas, bien sûr, il faut faire la sérieuse.

Lorsqu'il y a une connexion qui n'est pas au niveau du cul-sac de doublat, le cul-sac de doublat est accessible par voie vaste. Pourquoi je vais aller faire toute une gymnastique pour aller accéder par voie haute? Il vaut mieux accéder par voie vaste. Une incision, c'est le puissant, vous avez drainé votre absinthe.

Donc, ce qu'on appelle la cul-dosynthèse, une cul-dosynthèse en fonction du cul-sac de doublat, lorsqu'il y a une masse, ça s'appelle la cul-dosynthèse. Il y a une autre indication qu'on fait de moins en moins lorsqu'on suspecte un hémopéritoire dont une grossesse extra-utérine. Maintenant, l'échographie, elle est très compétente, mais parfois, jadis, il n'y avait pas d'échographes.

Une femme qui a un retard de rêve, qui a une tension imprenable ou bien une hypotension, pâle, anémique, on suspecte chez elle un épanchement, une hémorragie interne, c'est-à-dire une GU qui s'est rompue. On fait le doublat, si on a un bon moment du doublat, on fait une soirée et on inspire. Si on inspire du son, c'est une cul-dosynthèse qui est positive.

Donc, il y a un hémopéritoire. Il faut ouvrir pour faire l'hémostase. Ça, c'est lorsque, maintenant, vraiment, on fait de moins en moins.

Mais le concept, c'est le même. Un abcès au niveau du doublat, on fait la spéculum, on peut faire une cul-dosynthèse. La différence entre cul-dosynthèse et cul-dosynthèse, vous devez la connaître.

Cul-dosynthèse, c'est une ponction. Cul-dosynthèse, c'est incision. Pas le parasyntèse.

Parasyntèse, c'est une ponction, une collection. Synthèse, en général, c'est une ponction. Tomi, c'est ouvrir.

C'est ouvrir. La parotomie, c'est ouvrir la paroi. La parotomie est égale à la séliotomie.

La sélioscopie, la paroscopie, c'est la même chose. Donc, cul-dos-tomi, c'est ouverture du cul-sac de doublat. Cul-dosynthèse, c'est ponction de doublat qu'on faisait jadis dans les suspicions d'imants pérétoines dues à une grossesse extra-utérine rompue.

Alors, donc, doute, diagnostic, signe de gravité, collection autre que abcès du doublat et absence de réponse clinique après 48 heures de traitement antibiotique bien adapté qu'on va voir tout à l'heure. Donc, est-ce que la sélioscopie, elle est systématique? Est-ce qu'elle est obligatoire? Donc, il y a des indications précises. Maintenant, quand il y a le doute avec l'âge jeune, maintenant, lorsqu'il y a un doute.

Lorsqu'il y a un doute, lorsque ça répond pas bien au traitement, lorsqu'il y a une collection autre que abcès du doublat. Quels sont les intérêts de la sélioscopie? Parce que sélioscopie dans les infections génitales hautes, c'est parmi les indications les plus classiques, les premières indications de la sélioscopie. Ça permet de voir.

Elle a un intérêt diagnostique. Toujours quand vous parlez de la sélioscopie dans n'importe quel examen clinique, ce que vous voulez. Dis-moi quand vous allez au chapitre sélioscopie.

Il a trois intérêts. Un intérêt diagnostique. Ça permet de voir.

Elle a un intérêt pronostic. Ça permet de voir l'étendue des lésions. Le pronostic, est-ce que c'est juste limité ou bien c'est étendu? Elle a un intérêt thérapeutique.

Ça permet de faire des gestes. Donc, diagnostique, ça voit. Pronostic, ça regarde l'extension.

Thérapeutique, ça fait des gestes. D'accord? Sélioscopie, toujours trois choses. Diagnostique, pronostic, thérapeutique.

Alors, diagnostic, seul examen permettant de poser le diagnostic de certitude. Trompe. On va voir des trompes.

Eudématie inflammatoire. Des trompes. Eudématie.

Gonflée. Rouge. Ça permet d'explorer toute la cavité.

Toute la cavité abdominale et à plus forte raison, la cavité épidémienne. Une exploration de l'ensemble de la cavité péritoniale, notamment les adhérences avec le foie. Avec la région hépatique, le syndrome de Fitz-Curtis ou bien Curtis, c'est la même chose.

C'est un syndrome qui est très connu. Ma qu'est-ce que c'est? On parle pas de ce syndrome-là. C'est dû au climédias, c'est une infection génitale haute qui est tendue.

Les adhérences en accordéon, accordéon. Instrument de musique. C'est des adhérences en accordéon.

La capsule de glissant jusqu'au niveau des des envers des trompes. C'est la même chose. Donc ça permet de voir s'il y a ces adhérences-là et ça permet de faire des prélèvements.

Un diagnostic, ça permet de de prélèvements bactériologiques, le cul sec de Douglas et des trompes. Et bien sûr, en plus, on va voir l'appendice, est-ce que c'est pas elle qui est responsable de cette douleur-là? Parce que jusqu'à présent, on a douleur, il y a de la fièvre, on n'arrive toujours pas, surtout si c'est latéralisé, qui est concurrentiel avec les infections génitales hautes. Lorsque c'est à droite, on va toujours évoquer les deux.

Toujours chez la femme, lorsque vous avez une douleur, elle vienne. Surtout latéralisé à droite, l'appendicite ou l'infection génitale haute, toujours on va jongler entre ces deux diagnostics bien sûr avec les autres. On va vérifier l'appendice, c'est ce qu'il est, un appendice normal, on le voit, il est souple, il est normal, lorsqu'il y a un absent appendiculaire, on le voit, on peut même le traiter.

Donc, ça, c'est l'intérêt diagnostique, l'intérêt pronostique, ça permet de voir l'étendue des lésions pour la fertilité ultérieure. Évalue la sévérité des lésions, on voit le nombre, les fosses membranes, les abcès, les adhérences. Et ça permet de prédire.

Je vous ai dit que lorsque les trompes sont malades, sont infectées, la restitution ad integrum, c'est ce qu'on appelle ça. Ça n'existe pas. La restitution ad integrum, on essaie de limiter au maximum les séquelles en traitant bien et en traitant le plus précocement possible, c'est-à-dire faire le diagnostic rapidement, mais retrouver l'état initial jamais.

Donc, là, c'est lieu où c'est parmi les moyens de bien traiter. Dans ces cas-là. Lorsque c'est étendu, thérapeutique, ça permet de détruire de façon, de façon gentille, de façon atraumatique, d'éventuelles adhérences pyrithubo-ovariens.

Pyrithubo-ovariens, les adhérences entre la trompe et l'ovaire. Lorsqu'il y a des adhérences là, on ne peut plus avoir de grossesse si jamais on n'enlève pas ces adhérences. Ce qu'on appelle la désiolyse.

Donc, ça permet d'enlever ces adhérences. Ça permet de placer des drains, un drainage. Ça permet de laver.

Pourquoi? Toilettes péritoniales. Le lavage. On lave le maximum.

C'est forcément brun, ce pu qu'on essaie d'évacuer. On laisse un drain. Bien sûr, avec les antibiotiques.

On espère que au moins les trompes vont rester perméables avec le minimum d'adhérence possible. Ça, l'intérêt de la stéioscopie. Par contre, lorsqu'on n'est pas dans les indications là, lorsque c'est découvert à un temps précoce, douleur, fièvre, prélèvement positif, avant qu'on ait la réponse positive.

Dès qu'on suspecte chez une jeune qui a des facteurs de risque, douleur à la mobilisation, on commence les antibiotiques rapidement. Souvent, on n'a pas besoin d'arriver à la stéioscopie. Si après 48 heures, les choses ne vont pas.

Pourquoi? Pourquoi une infection génitale haute ne va pas répondre aux antibiotiques? Après 48 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a un abcès. Parce qu'il y a une coque.

C'est que s'il y a un doute de diagnostic, bien un abcès. Il faut faire la stélio pour aller détruire. Si on n'a pas la stélio maintenant, malheureusement, parfois on n'a pas la stélio au niveau des urgences.

On fait carrément des des la parotomie médiane sous l'ombilical. On fait des incisions pour aller laver, faire des prélèvements et drainer. Mais ce n'est pas aussi aussi minutieux qu'une stéioscopie.

Si je peux, ça permet de voir tout, de laver de façon correcte, de drainer de façon correcte, de faire des prélèvements de façon correcte. La parotomie, c'est un petit peu. On n'est pas aussi.

On ne va pas bien laver comme si on fait avec la stélio. Donc les trois intérêts de la stélio dans le cadre du bilan de dans le cadre du bilan déjà du bilan d'une infection génitale. Ça, je l'ai ajouté également dans cette année-là.

Lorsqu'une femme a un Dieu, il fait une infection, il a fait une infection génitale ou là, une maladie infirmière du pelvis. Un épisode d'infection génitale haute chez la femme porteuse d'un Dieu n'indique pas son retrait. Voilà donc.

Non, c'est une complication. Retenez complication. J'ai pas de réponse.

J'ai pas de réponse parce que ça se trouve avant. Avant ce cours là, on enlevait systématiquement les dieux. Maintenant, en moins, on a cette notion lorsque le Dieu a plus d'une année, deux ans, s'il fait une infection génitale haute, non compliquée.

Il n'y a pas d'abcès, il n'y a rien. Juste dans le traitement, on voit si les choses rentrent dans l'ordre facilement, rapidement, on n'a pas besoin d'enlever. Oui.

Alors, pour le Dieu avec l'histoire des six semaines, quand est-ce que le Dieu est un facteur de risque de maladie inflammatoire du pelvis? C'est lorsque on est dans les six semaines après la pause. Si on dépasse les six semaines, c'est pas le Dieu qui a entraîné l'heure. Bien sûr, il faut l'enlever.

Normalement, logiquement, il faut l'enlever. C'est lui qui a été responsable. Peut-être que c'est lui qui était infecté.

Donc, logiquement, il faut l'enlever. Mais ça, c'est une nouveauté. Donc, avant.

Avec Dieu, il faut enlever le Dieu et envoyer le Dieu au laboratoire pour être pour bactériologie. Maintenant, dans les récents revues que j'ai vues, c'est plus une indication dans ces cas-là que lorsqu'il y a une complication. Le retrait du sera discuté en cas de complication ou au cas de mauvaise évolution dans l'étroit à cinq jours suivant le début de l'antibiothérapie.

Donc, il y a un abcès. Il faut l'enlever. Ou bien on a donné des antibiotiques.

Peut-être qu'on n'a pas bien vu l'abcès à l'imagerie. Ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas.

Je vais poser l'indication de Célio, mais je dois également retirer le Dieu pour un corps étranger. La femme n'arrive pas à avoir une défervescence. Il a toujours mal.

J'enlève le Dieu. C'est très logique. Il faut l'enlever.

Ceci concernant les diagnostics différentiels, bien sûr, ceux des douleurs pelviennes abdominales. On va évoquer l'appendicite à deux les diagnostics différentiels lorsque vous avez une douleur. Vous avez évoqué tout ça chez une femme.

L'appendicite, l'assistite, l'infection urinaire basse, ça donne des douleurs pelviennes. La grossesse extra-utérine, toujours on l'évoque. Une torsion d'annexe.

Une torsion d'annexe. C'est l'équivalent de torsion chez le garçon. Parfois la tellement il est mobile, parfois il peut se tordre.

Il faut faire le diagnostic dans les six heures pour essayer de la détendre pour la conserver. Torsion. Donc, les douleurs, douleurs aiguës rapidement avec vomissement, avec position en chaîne de fusil.

C'est très probablement quelque chose qui est en train de se tordre. Il faut ouvrir rapidement une cellulose coupée pour détendre. Pathologie épato-biliaire.

Ça peut donner des douleurs pelviennes. Une gastrite parfaite peut donner des douleurs pelviennes. Une sigmoïdite peut donner également des douleurs pelviennes.

Tout ça, ce sont les idéologies des douleurs pelviennes. Si vous avez une douleur pelvienne, toujours évoquer ces diagnostics là. Et vous essayez de voir le pour et le contre devant chaque diagnostic.

Par exemple, une gastrite, quelqu'un qui est connu, ulcérant, vous allez évoquer la gastrite, mais s'il n'est pas connu, ulcérant, n'est pas fumeur, on ne va pas l'évoquer. Si il a du brûlure

mixionnelle, c'est plutôt la cystite, douleur épigastrique avec brûlure mixionnelle, sans le coré, donc c'est plutôt la cystite, torsion d'annexe, quelque chose, c'est vraiment, c'est l'extrême de la douleur. La douleur de la torsion d'annexe, c'est la douleur la plus extrême.

Bien sûr, juste après la pancréatite. Vous savez que la pancréatite, c'est la douleur la plus extrême. Peut-être que l'accouchement, c'est encore plus douloureux que tout ça, mais je dois vérifier. L'accouchement, c'est très douloureux.

Surtout quand on ne s'est pas bien préparé. Les complications, donc tout ça pour ça. Alors les complications, grosso modo, aiguë, à court terme, à moyen terme, à court terme et à long terme.

Essentiellement à court terme et à long terme. À court terme, on peut avoir les abcès, tout ce que vous voulez. Donc abcès, pus alpinx, abcès tubo ovarien, abcès du Douglas.

Diagnostic dialogue, c'est un tableau de frissons, de fièvre, tout ça, douleur à la mobilisation et en plus à l'échographie, vous avez une masse. Ou bien vous n'avez pas trouvé la masse à l'échographie, mais que vous avez donné le traitement et ça ne répond pas normalement correctement. Ça doit répondre dans les 48 heures.

Je dois faire le scanner, je dois indiquer la cellulose. D'accord? Ça, c'est les abcès. Traitement à un abcès, il faut traîner par la voie la plus facile.

Pilvis péritonite, ça, on n'a pas un organe qui est siège de l'abcès, mais toute la partie péritoniale du pilvis, on peut même avoir une collection dans le doigt, une collection sans être abcédé. Comme un épanchement, comme une assise, comme un épanchement, c'est ça le pilvis péritonite. A l'échographie, vous avez une lame d'épanchement, c'est ça le pilvis péritonite.

Donc, péritonite à point de départ tuber, complications fréquentes des pilvis inflammatory disease, mais insuffisamment traitées. Donc, les abcès et le pilvis péritonite, dont les complications aiguës. Voilà un aspect stéréoscopique d'une trempe qui est rouge, boudinée, inflammée, très probablement qui renferme du pus à l'intérieur.

Quand on voit ça en stéréoscopie, ça, c'est l'utérus, c'est le fond utérin. C'est rouge. Parfois, on peut trouver des collections à ce niveau-là.

Le traitement, on le voit, il faut ouvrir. Il faut ouvrir tout ça afin de drainer l'abcès, aspirer, laver. Et bien sûr, envoyer à la bactériologie.

Donc, complications aiguës à court terme. Complications, il y a la récurrence. Parfois, vous traitez, si le traitement n'est pas très bien fait, il y a un risque de récurrence.

C'est connu. La trempe, c'est un organe qui est profond, parce qu'il y avait un abcès. Vous traitez, vous devez surveiller.

Il faut surveiller après trois mois, après six mois, faire des prélèvements. Parce qu'ils sont connus comme responsables de récurrence. Même si vous traitez correctement, il faut revoir la femme trois mois après faire un prélèvement.

Il faut qu'elle soit stérile. Bien sûr, il faut qu'elle ne présente pas de symptômes autologiques. Il faut que le prélèvement soit stérile.

On la reconvoque également six mois après, parce qu'il y a un risque de rechute rapide. Ça, c'est les rechutes rapides. Les récurrences rapides.

Pour les complications tardives, on va parler de l'infertilité tuber. Première cause d'infertilité tuber, ce sont les infections génitales hautes. C'est la première cause.

L'HGU, l'infection génitale haute, multiplie par 10 le risque de GUE par rapport aux femmes qui n'ont pas fait d'infection génitale haute. Donc, l'infertilité, l'HGU, la récurrence, on en a parlé. La chronicité, ça devient un truc chronique.

Comment on va le savoir? Les douleurs pelviques chroniques, des douleurs au moment des rapports sexuels, ce sont les deux disparités. Et bien sûr, les adhérences avec le foie, ça va entraîner également des douleurs chroniques. Donc, les douleurs chroniques, parfois, elles sont très invalides.

La femme consulte tous les deux semaines, trois semaines parce qu'elle a mal. On ne peut rien faire parce que c'est des séquelles d'une pathologie qui n'a pas été soit bien prise en charge ou bien qui avait un retard diagnostique. Les douleurs chroniques, c'est toujours les avoir.

Bien sûr, un petit mot sur les avortements spontanés. Parfois, avec la chronicité, on peut avoir une implantation et que l'implantation, la grossesse ne va pas jusqu'au bout. La femme fait des fausses couches précoces.

Parmi les causes des fausses couches précoces, ce sont les séquelles d'infection génitale haute. Donc, tout ça, ce sont les complications tardives. Et on arrive au traitement.

Donc, on a encore 20 minutes, 25 minutes. Alors, le traitement, on va parler de généralité. Pourquoi traiter? Par rapport au cours de l'année dernière, on avait dit toute infection génitale haute, il faut hospitaliser.

L'hospitalisation, elle est obligatoire. Maintenant, on va nuancer parce qu'il y a des infections génitales hautes lorsqu'elles ne sont pas compliquées qu'on peut traiter. Comment? On est obligatoire.

Ça, c'est la grande différence par rapport au cours de l'année dernière. La médecine, ça évolue. Maintenant, on a des prélèvements, on peut confirmer les diagnostics.

On a des échographies à côté. On a des scanners. Donc, on a des cellulaires.

Donc, maintenant, on peut bien évaluer la femme. Pourquoi on hospitalise? Parce qu'on a peur de l'envoyer et que de laisser évoluer un truc qui devait être opéré rapidement. On va voir le traitement médicamenteux, le traitement chirurgical, il a quand même une place, des mesures associées, comment on surveille après le traitement et comment la prévention.

Donc, en généralité, l'autorité est recommandée pour Si c'est le mois aussi, donc uniquement sans signe de complication, il n'y a pas d'abcès, il n'y a rien et que le traitement 48 heures, il a réglé le problème. Dans ce cas-là, donc, on traite l'ambulatoire, mais on voit la femme deux jours à trois jours après. Absolument la voir.

Oui, j'ai entendu à la maison. S'il n'est pas compliqué, on a fait l'échographie, il n'y a pas de collection, il n'y a pas de syndrome infectieux très sévère, la serpe n'est pas très élevé, c'est des cas vraiment très sélectionnés. Ma patate, je dis qu'infection génitale haute égale hospitalisation.

Comment? On va la revoir, donc on va le voir dans la surveillance. La surveillance a des cas ambulatoire, on doit la revoir trois jours après pour voir l'évolution. Pour les infections génitales hautes sans signe de complication, c'est parce que c'est très important.

Alors, en hospitalisme, bien sûr, dans le service de gynécologie, s'il y a une indication de célioscopie, c'est-à-dire les indications qu'on a vu tout à l'heure, le doute, la non-réponse après quarante-huit heures, le doute et les infections lorsqu'il y a déjà une complication, un abcès ou autre chose. Par fonction transvaginale d'un abcès pélvien ou tubaux ovariens. Donc, si indication d'une cellule ou d'un drainage.

Donc, l'hospitalisation lorsque il y a indication d'une cellule ou d'un drainage, s'il n'y a pas de complication, s'il n'y a pas d'abcès, s'il n'y a pas de doute diagnostique, c'est-à-dire qu'il va indiquer une cellule. On n'a pas. On peut traiter en ambulatoire.

Mais on va voir le traitement. Comment il est? L'antibiothérapie probabiliste. Le traitement médicamenteux, c'est triple antibiothérapie probabiliste.

Triple. L'année dernière là, on commence par trois. Triple antibiothérapie parce que il y a le il y a le il y a le strepto.

Donc il faut il faut pour traiter à la fois les germes intracellulaires, le chlamydia, le gonocoque, c'est un diplocoque à l'examen direct en bactériaux. Ils ont un aspect caractéristique des diplocoques. On garde de raisins.

On garde du café. On garde du café. Ils ont un aspect à l'examen direct jusqu'au prélèvement.

Examen. On peut faire le diagnostic. Ça, c'est des choses anciennes.

Donc, triple antibiothérapie probabiliste pour traiter à la fois les germes intracellulaires, le gonocoque, les entérobactéries, c'est-à-dire les BGN et les anaérobies. Les fluons qu'ils n'ont, surtout à long terme, on doit les laisser en deuxième intention. Je vais donner un exemple de traitement.

Voilà l'exemple. Le un traitement minute. C'est le pilier, c'est les vrais antibiotiques des germes du chlamydia.

Par jour, soit par voie orale, soit par voie intraveineuse. Donc, traitement minute euh, cinq cent la short piece parce qu'on est sûr que c'est une short piece, que c'est une rutrice, surtout c'est les hommes. Deux cent cinquante euh, cinq cent, deux cent cinquante.

Cinq cent milligrammes du une injection et c'est un traitement minute. Donc, c'est très extrême d'oxycycline pour pour les anérobies 500 fois 2, soit par orale. La durée totale du traitement est de 10 jours lorsqu'il n'y a pas de complication, lorsque c'est simple, il n'y a pas d'abcès, il n'y a rien, et prolongé à 14 jours ou bien plus lorsque il s'agit d'une infection génitale haute, donc IGS, infection génitale haute compliquée.

Tout simplement, triple antibiothérapie probabiliste visant les germes intracellulaires, visant les anaérobies et visant le gonocoque et visant les BGL. L'archéologie, c'est lorsqu'il y a un doute ou bien l'absence d'amélioration au bout de 48 heures d'une bonne antibiothérapie ou d'emblée lorsqu'il y a une complication, bien sûr, lorsqu'il y a soit un abcès du doublard, soit un abcès tubo-ovarien ou bien un pioche alpinx, ou bien un pilivre péritonique, comme l'a dit Mme Maléky-Nouza. Bien sûr, le traitement chirurgical, l'idéal, c'est par celluloscopie, on a vu les intérêts de la celluloscopie.

Alors, quelles sont les mesures associées ? Bien sûr, c'est un réflexe de médecine générale. Les patients sous cyclines, il faut leur conseiller de ne pas s'exposer au soleil vu le risque de photosensibilisation cutanée. C'est un réflexe.

Bien sûr, il faut voir les partenaires, les examiner et demander un bilan, moindre doute. Lorsque le partenaire, lorsqu'on suspecte qu'il y a un cas immédiat, on peut donner l'azithromycine, un gramme en prise unique chez le partenaire lorsque c'est le cas immédiat. Lorsque c'est autre chose, lorsqu'il est symptomatique, il faut donner le même traitement que la femme.

Bien sûr, comme mesure associée, il faut que les rapports soient protégés jusqu'à la fin du traitement. Et avant d'autoriser les rapports sexuels, il faut qu'il y ait un prélèvement qui est négatif, un prélèvement cervico-vaginal négatif qui va vérifier la guérison. Alors, la surveillance, si le traitement est fait en externe, c'est-à-dire en ambulatoire, la question que vous avez posée tout à l'heure, réévaluation clinique entre 3 et 5 jours après le début des antibiotiques, température, douleur et l'occorée.

Normalement, il ne doit plus y avoir de température, ni de douleur, ni d'occorée. La première

chose qui disparaît, c'est la température, les douleurs et l'occorée un petit peu. Mais en général, 48 heures, 3 jours, on a soit amélioration, soit stagnation.

Amélioration, c'est un bon signe, stagnation, c'est l'oscopie. Bien sûr, on va faire un scanner pour voir s'il n'y a pas de masse, parce que parfois l'échographie peut ne pas avoir une petite masse, parfois. Donc, en cas de traitement efficace, la disparition des symptômes en moins de 4 jours.

Alors, comment on a passé le traitement, on a vu quand est-ce qu'on est hospitalisé, quand est-ce qu'on est traité en ambulatoire, on a vu le traitement médical triple antibiotérapie qui est probabiliste, qui vise les germes intracellulaires, le gonocoque, les BGN, les anaérobies. On a donné un exemple, on a vu les moyens associés pour traiter le partenaire. C'est du chlamydien, on peut donner une dose, un traitement minute par la zitromycine, un gramme.

On a vu, on va parler de prévention avant de voir comment on va agir dans la prévention. Bien sûr, la prévention, c'est les préservatifs, c'est le péril des infections génitales, c'est les préservatifs. Bien sûr, les partenaires, il faut les dépister.

Le certificat prénuptial, le certificat prénuptial normalement doit comporter un dépistage d'IST chez les deux. Normalement, l'utilisation systématique des préservatifs des patients ne connaissant pas le statut de leur partenaire en termes de contamination par le VIH et par les autres IST. Donc, l'utilisation des préservatifs, le dépistage régulier des IST, si un partenaire s'échange de partenaire, il doit avoir un bilan d'IST chez le partenaire.

Ça, c'est si on veut parler prévention. Préservatif avec bilan IST, la prévention fait un préservatif et les bilans IST. Georges, l'éducation, préservatif, bilan d'IST, là, l'éducation, l'éducation, les jeunes avant les rapports sexuels, il faut leur dire préservatif, bilan d'IST chez les partenaires.

C'est ce qu'on va dire. Donc, préservatif, dépistage régulier d'IST chez les partenaires, surtout s'échangent, le traitement des patients et du partenaire en cas de diagnostic d'IST et bien sûr l'éducation des patients dès le début de leur sexualité. Les jeunes, c'est pour ça que ce sont les jeunes qui font beaucoup plus d'infections génitales basses parce qu'ils ne savent pas comment se protéger contre les IST.

Qu'est-ce qu'on demande dans le bilan de dépistage? Là, ça, c'est le bilan de dépistage, ça, c'est lorsqu'on veut faire un certificat prénuptial avant le mariage. VIH, là, on ne demande plus, ça reste à discuter quand même. Chlamydia par PCR, hépatite B et C en fonction du contexte et syphilis.

D'abord, le bilan prénuptial avec l'HIV en général. Sincèrement, je n'ai pas eu de refus de faire le VIH chez une patiente chez qui je veux presque le VIH. Au contraire, il y a même des femmes qui demandent, je veux avoir mon statut VIH et celui de mon conjoint.

En général, c'est les deux qui viennent pour avoir le certificat. Je n'ai jamais, je vais vous

demander ça, ça, ça, il n'y a pas de problème. Donc, VIH, chlamydia, PCR, hépatite B et C en fonction, je le demande systématiquement et TPAVDRL de la syphilis.

Donc, j'arrive à la conclusion. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de questions. On va voir un petit peu.

Est-ce qu'il y a des questions pour la discussion? Aucune question. Parfait. Donc, ce sont les 100, je clique sur le terme, je dis subiguë.

Subiguë, il y a frustré, il y a pensée symptomatique, il y a trompeur, il y a... Subiguë, c'est-à-dire que ce n'est pas la forme typique. Difficulté diagnostique, ça, on a vu. Dans 85% des cas, c'est des infections sexuellement transmissibles.

Les manœuvres endo-utérines dans 15% des cas. Les infections transmissibles dominées largement par le chlamydia dans plus de 70% des cas. Qui est souvent asymptomatique, mais qui est très agressif.

Le gonocoque en deuxième position, les mycoplasmes en troisième position. Pour les endo-utérins, c'est surtout les BGN, les chirurgiens coulis et les anaérophiles. Pour le diagnostic, l'interrogatoire, la recherche des facteurs de risque.

On a vu les facteurs de risque, les jeunes, moins de 20 ans, la précocité des rapports sexuels, les partenaires, l'absence de protection par les préservatifs et l'absence de dépistage. La clinique, rarement, on a le tableau typique. Si vous avez la douleur, la fièvre, les loqueries pathologiques et les douleurs à la mobilisation de l'utérus, quatre, fièvre, douleurs, loqueries pathologiques, douleurs à la mobilisation de l'utérus, c'est presque pathogamonique.

On fait l'échographie pour voir s'il y a un abcès ou non et on commence le traitement. S'il y a un abcès, si le traitement qu'on a commencé n'a pas bien évolué dans 48 heures, c'est l'indication de la CELIO qu'il y a trois objectifs. Un objectif diagnostique, un objectif pronostic et un objectif thérapeutique.

Le traitement, on peut se faire un ambulatoire à condition et seulement s'il n'y a pas de complications. L'hospitalisation est faite lorsqu'on a un doute diagnostique, lorsqu'on veut faire une CELIOSCOPIE. Donc je pense qu'on a tout vu.

Le bilan d'IST, il faut le faire au moment du traitement chez le partenaire et on peut le faire à pré-nuptial dans le cadre du dépistage d'IST. L'HIV, la PCR du chlamydia, la syphilis, l'hépatite B plus ou moins C. Ne pas oublier la grossesse en cas de douleurs péloriennes. C'est une règle pour toutes douleurs péloriennes chez une femme en période active digitale.

La DDR, s'il y a un doute, le test de grossesse. Et je vous remercie.